

Jedzenie emocjonalne

4-krokowy protokół: pauza, pytanie, pozwól, wybierz

Otwierasz lodówkę i nie wiesz, czego szukasz. Sięgasz po słodkie po obiedzie, mimo że nie jesteś głodna/głodny. Jesz wieczorem przed Netflikiem, choć jadłeś godzinę temu. To nie kwestia woli — to nawyk regulacji emocji przez jedzenie.

Walka z tym nawykiem dietami zwykle kończy się podwojeniem — bo ograniczenie jedzenia uruchamia stres, a stres uruchamia jedzenie. Ten protokół pracuje inaczej: nie ogranicza, tylko wprowadza pauzę.

Oparte na badaniach Judson Brewer (Yale, Brown). „Jedzenie z ciekawości, nie z impulsów” — protokół mindful eating ze skutecznością 28% redukcji emocjonalnego jedzenia po 8 tygodniach.

Pierwsza zasada: nie eliminuj — rozpoznaj

Ta praca nie polega na rzucaniu jedzenia emocjonalnego. Polega na rozpoznaniu, kiedy jesz z głodu, a kiedy z innego powodu — i na świadomym wyborze w drugim przypadku.

Czasami wybór będzie: zjedz tę tabliczkę czekolady. To OK. Klucz w tym, że to był wybór, nie autopilot.

Cztery kroki

Krok 1 • Pauza

Kiedy: w momencie, gdy sięgasz po jedzenie, które nie jest planowanym posiłkiem.

Co robisz: zatrzymuje rękę w połowie ruchu. 3 oddechy. Nie mówisz „nie”. Mówisz „chwilka”.

Sama pauza już jest interwencją — przerywa autopilot. Nawet jeśli potem zjesz, cykl jest inny.

Krok 2 • Pytanie

Po pauzie zadaj sobie 3 pytania — w myślach, w 30 sekund:

Trzy pytania diagnostyczne

1. Czy mam głód fizyczny? — czy żołądek się kołata, brzuch jest pusty, czy miałbyś ochotę też na warzywa, nie tylko na chipsy?

2. Czy ostatnia rzecz, która mi się przydarzyła, była niemiała? — rozmowa, mail, myśl, nuda, samotność?

3. Czego naprawdę teraz potrzebuję? — odpoczynku? rozmowy? ruchu? świeżego powietrza?

Krok 3 • Pozwól

Tu jest klucz, który większość protokołów pomija. Jeśli to nie jest głód — nie walcz z emocją, która jest pod spodem.

Pozwól sobie poczuć: smutek, znudzenie, lęk, tęsknotę. 60 sekund. Po prostu zauważ jak to czuję ciałem.

Brewer pokazał w skanach mózgu, że 30–90 sekund świadomego przeżywania emocji wystarcza, żeby fala minęła. Walka z emocją (lub jedzenie które ją tłumi) przedłuża ją.

Krok 4 • Wybierz

Po 60 sekundach pytań i emocji — masz wybór. Możesz:

Trzy możliwe wybory

Zjedz, ale świadomie. Usiądź. Bez ekranu. Smakuj. Powoli. Po pierwszym kęsie zapytaj — czy jeszcze chcę? Po połowie — czy jeszcze chcę?

Zaspokoj prawdziwą potrzebę. Jeśli to był smutek — zadzwoń do kogoś. Nuda — wyjdź na 5 minut. Zmęczenie — połóż się na 10 minut. Stres — trzy fizjologiczne wzdechy.

Po prostu nic. Czasami pytania pokazują, że impulsacja była chwilowa — mija po pauzie. Wracasz do tego, co robiłeś.

Nie każdy raz działa wszystko. Pierwsze tygodnie będziesz często wybierać „jedz, ale świadomie”. I OK. Po 4-6 tygodniach zaczniesz częściej wybierać opcje 2 i 3 — bo mózg zauważy, że jedzenie nie było tym, czego naprawdę potrzebowałeś.

Trzy najczęstsze wzorce

Wieczorne „nagroda po dniu”

Sygnał: jesz po 21:00 mimo że jadłeś godzinę temu. Często przed Netflixem.

Pod spód siedzi: „ten dzień był ciężki, zasługujesz na coś”.

Co działa: rytuał nagrody, który nie jest jedzeniem — gorąca kąpiel, fragment serialu z herbatą, krótkie ćwiczenie z wdzięczności.

Stresowe podjadanie

Sygnał: trudna rozmowa, zaraz potem — lodówka.

Pod spód siedzi: jedzenie jako fizyczne uziemienie po pobudzeniu sympatycznym.

Co działa: wyjdź na 5 minut. Trzy fizjologiczne wzdechy. Lampka zimnej wody. Dopiero potem, świadomie — jeśli nadal chcesz jedzenia.

Nudne podjadanie w pracy

Sygnał: w 15:00 rzucasz się na cukier. Codziennie.

Pod spód siedzi: spadek energii (głód fizjologiczny) + brak struktury (potrzeba przerwy).

Co działa: zaplanowana przerwa o 14:30 — spójrz w okno, zjedz orzechy + owoc, wyjdź na 5 min.

Kiedy potrzebna pomoc 1-na-1

Jeśli jedzenie emocjonalne wynika z trauma, depresji, lub utrwalonych mechanizmów z dzieciństwa — samodzielny protokół może być niewystarczający. Hipnoterapia może pomóc rozplatać skojarzenia jedzenia z konkretnymi emocjami.

Jeśli podejrzewasz zaburzenie odżywiania (kompulsywne objadanie, bulimia, anoreksja) — nie pracuj sam. Skontaktuj się z psychoterapeutą lub ośrodkiem leczenia zaburzeń odżywiania.

Ten protokół jest narzędziem rozwojowym. Nie zastępuje terapii ani leczenia. Jeśli problem utrzymuje się mimo regularnego stosowania — warto sięgnąć po wsparcie 1-na-1 (psychoterapia, hipnoterapia, lekarz).

Tomasz Bochenek · Hipnoterapeuta · Gdańsk
hipnoterapiabochenek.pl · @hipnoterapiabochenek

Materiał do użytku osobistego. Hipnoterapia jest wsparciem rozwojowym i nie zastępuje opieki medycznej ani psychiatrycznej. Jeśli doświadczasz myśli samobójczych lub objawów ostrej choroby psychicznej — zadzwoń na 116 123 (Telefon Zaufania) lub 112.